本章数字资源

第八章 以社区为范围的健康照顾

学习提要

- 培养以社区为范围健康照顾的思维和基本能力。
- 理解社区的史源与概念及发展社区医学的深远意义。
- 知悉以社区为导向的基层医疗，把纯粹的医疗方式扩大到对社区人群的管理。
- 重视群体健康及普遍的公共卫生问题，懂得使用社区调查及社区诊断手段，以有效、群体参与的方式促进社区康复。

人体与环境息息相通，机体随时与外界进行空气、物质、信息的交换。因生活的需要，人群居住在一定的地域，形成了活动的范围——社区（图 8-1）。人类数个世纪遭受疾病和瘟疫的侵袭之后，反思社区卫生的重要，为了保护生存的环境不受疫疠肆虐，由此产生了社区医学。其理念是社区也像人一样，会有这样那样的健康问题，需要像对患者一样进行分析、诊断和治疗，以消除影响人群健康的隐患，营造良好的社区环境，使人们在这里心情舒畅、免受伤害、享有保健和健康，让社区成为友谊和温暖的大家庭。



图 8-1 社区充满了友谊

第一节 | 社区医学

1977 年第 30 届世界卫生大会提出了“人人享有卫生保健”的目标，1978 年阿拉木图宣言确定了推进初级卫生保健是其实现的唯一途径，使得社区医学得以发展。

一、社区

（一）定义

社区（community）伴随着人类的出现而产生，在上古氏族社会就有了社区的雏形，人群是构成社区的重要元素。社区由德国社会学家滕尼斯（F. Tonnies）1881 年首次提出，定义为“以家庭为基础的历史共同体，是血缘共同体和地缘共同体的结合”。英文 community 的原意是公社、团体、共同体、同一地区的全体居民。“社区”一词是由社会学家费孝通等于 1933 年引入我国。费孝通定义社区为，“若干社会群体（家庭、氏族）或社会组织（机关、团体），聚集在某一地域里所形成的一个生活上相互关联的大集体”。社区不同于行政区域划分，更趋于一组共同生活、具有共同特征和共同需求的区域人群组成的社会。聚集在这一地域的社会群体，生活上互相关联，从事文化、经济、政治等社会实体活动。不同的学者、不同学科对社区定义的理解有不同定位和倾向，比较权威的是世界卫生组织提出的社区定义：社区是因某种经济的、文化的、种族的或某种社会凝聚力，使人们生活在一起的一种社会组织或团体。

（二）社区的类型

社区分为地域型社区和功能型社区。地域型社区以一定的地理范围为基础，生活在此范围的居民享受共同的基础设施服务，由区域内的机构和制度所管理。功能型社区以共同的特征为基础，如有

共同的兴趣、爱好、价值观等，由此而聚集在一起，形成相互联系的机构或组织。

（三）社区的要素

（1）一定的人口构成：人口约为 10 万~30 万。

（2）一定的地域空间：面积 5 000~50 000km^2。

（3）相应的经济活动：社区居民的生产、交换、分配和消费等经济活动。

（4）区域内的各种服务设施：分为面向全体居民的服务和面向特殊群体的服务。面向全体居民的服务包括医疗卫生服务、家居生活服务、综合环境治理服务等；面向特殊群体的服务包括老年人服务、残疾人服务等。

（5）心理认同感、归属感：共同的文化背景、生活方式和认同的意识。

（6）相应的管理机构和制度：街道委员会、居民委员会、居民自治性组织等。

二、社区医学概述

（一）社区医学概念

20 世纪 60 年代不少学者提出，社区医学（community medicine）是确认和解决有关社区群众健康照顾问题的一门科学。通常采用流行病学、医学统计学方法进行社区调查，作出社区诊断（community diagnosis），确定社区群众健康问题及其医疗保健照顾的需求，并拟订出社区健康计划，动用社区资源，改善群体的健康问题，且对实施的健康计划进行评估，以达到预防疾病促进健康的目的。社区医学是一门充分发掘利用社区资源，满足社区卫生需求，富有卫生政策和管理机制的宏观公共医学。社区医学的特点是把人群中个体的普遍卫生问题，归纳到群体的机制，并与他们的家庭、社区和社会联系起来，去认识、分析和处理卫生问题。

（二）社区医学的产生

社区医学伴随着社区的形成而产生。16 世纪文艺复兴时期工业迅猛发展，大批手工业者纷纷涌入城市或聚集在工厂、矿山周围，形成了许多社区，由于生产生活条件极差，厂房住房简陋拥挤，通风不良，生产废水、生活污水、粪便垃圾四处排放，导致了各种传染病的流行和职业病的发生，对人群健康造成了极大危害。当时有远见卓识的医生发现了这些具有社会性的问题，纷纷进入社区进行调查研究，如 1493—1541 年，瑞士医生帕拉塞尔苏斯（Paracelsus）对矿山“水银病”的研究；1669—1714 年，意大利拉马兹尼（Benardins Ramazzini）对“手工业者疾病”的研究；1840 年，法国医生路易斯·里纳·菲勒米（Louis Rena Villermi）对纱厂工人的卫生条件进行研究；1848 年，鲁道夫·魏尔肖（Rudolf L K.Virchow）对西里西亚斑疹伤寒流行环境卫生的调查等，都强调了环境和社会因素对健康的影响。19 世纪英国的霍乱猖獗流行，人们从事实看清楚了单靠医院或某一位医生的努力已经不能控制疾病的发生，单纯的治疗不能解决面临的难题，必须从个体防治转到社区的防治，当初称为“公共卫生”；到 20 世纪初叶，公共卫生逐渐进入以社区为服务单位的趋势，强调不同社区的不同需求及自主性，改称“社区保健”；随着社会进步及学科发展，社区保健与流行病学、社会医学等结合，产生了社区医学，20 世纪 60 年代英国率先使用“社区医学”这一名词，并进行一系列以社区为范围的研究。

（三）社区医学教育

20 世纪 70 年代中期，社区医学教育（community medical education）在国外形成了完整的教学体系，根据社区卫生保健的需求和可利用的资源，为社区培养新型医师。是以个人、家庭和人群的健康促进、疾病预防、治疗和康复为重点，以培养从事社区卫生人才为目标的教育活动。

1. 社区医学教育围绕社区卫生保健需求设计培养目标。

2. 选择与社区卫生有关的预防医学、流行病学、卫生统计学、妇幼保健、优生优育、卫生宣教、卫生政策等方面的基本理论知识和技能，作为必修课程。

3. 深入社区实习基地，体验熟悉社区情况，包括人口结构、地理、社会环境、文化、民俗等。

4. 训练社区调查、社区诊断的能力，能提出干预措施，有处理实际问题的能力。

5. 掌握社区常见病、多发病的诊断治疗技能。

社区医学教育是突出社区大卫生的管理和人群疾病防治的定向教育，培养从事初级医疗保健的专门人才。因此，有许多发展中国家及发达国家的偏远地区仍延续社区医学的照顾模式。而发达国家的环境卫生、传染病等问题已基本解决，服务已转向以个人和家庭的心身问题为主的家庭/全科医疗模式。但对于我国的社区医生，必须兼顾社区医学及家庭医学知识和以社区为范围的基层服务。社区卫生服务，是以家庭/全科医生为依托，实施可及、经济、公正、高质量的基层卫生保健服务。其特点有：①符合社会效益、成本效益和经济效益；②社区人人参与；③形成卫生服务网络；④防、治、保、康一体化，政府、医疗、居委会共同参与；⑤重视发掘利用社区资源。成功的社区卫生服务可解决居民80%以上的健康问题。

三、以社区为导向的基层医疗

以社区为导向的基层医疗（community oriented primary care，COPC）最初是在20世纪30年代由以色列Sidney L.Kark提出，是其在以色列屯垦区多年实践经验的总结并推荐的基层医疗模式。Kark医生强调健康问题与社区的生物性、文化性、社会性特征密切相关，没有理由把初级保健局限于个体疾病的治疗，应该把服务的范围从单一的临床治疗扩大到社区，以流行病学的观点提供完整的照顾。此举后来为许多国外的社区所采用，成为同时解决个体医疗和社区保健问题的基层医疗模式，被称为“以社区为导向的基层医疗”。COPC是对社区医学和家庭医学在社区实践中的优化组合，以社区医学为指导，基层医疗为基地，以家庭/全科医疗的形式实施照顾。

（一）COPC的基本要素

COPC超越了医疗为患者的模式，以积极的健康观及防治为一体的过程，提供社区导向的连续性综合医疗。其3个要素为：基层医疗、社区人群、解决问题的过程。

（二）COPC的基本特征

以社区为导向的基层医疗服务一般具有以下特征。

1. 将社区医学的基本理论与临床医学的实践相结合。

2. 通过社区诊断确定社区的主要健康问题及危害健康的因素。

3. 制订可行的解决问题的干预方案。

4. 合理配置社区内的人力、物力、财力、组织等资源，实施健康项目，提供保障措施并进行效果评价。

5. 提供连续性、可及性的医疗卫生服务。

（三）以社区为导向的意义

以社区为导向的服务，其意义有以下几点。

1. 通过以社区为范围的服务，了解人群健康问题的缘由。仅从医院、诊所的疾病去研究健康，无法获得影响健康问题的完整因素。因此，维护个人、家庭的健康必须以社区为导向。

2. 社区里的健康隐患。以社区背景观察健康问题，以系统论将健康问题还原，暴露涉及的全部因素。忽视社区背景因素，疾病观狭隘，则不能科学地诊治慢性病和提供合理的照顾。

3. 以社区为范围，医生关心健康人群、求助者和患者，这样方能完整地维护居民健康，将预防、病患、传播方式包含其中。社区预防相比个体诊治对人群更具意义。

4. 以社区为范围的服务，能合理利用有限的卫生资源，动员群防群治，最大限度满足居民的健康需求。维护社区人群健康，是整个社区及社会的责任，社区积极参与可弥补卫生资源的不足，使维护健康的活动在政策、制度、行政干预下，成为全体居民参与的群众行为，达到以纯粹医疗无法取得的效果；也能更有效地控制疾病在社区的流行。

（四）COPC分级

0级：以传统的医疗模式，只对就诊者提供非连续性的医疗，没有社区的概念，不关注社区的健康问题。

1 级：对所在社区的健康资料有所了解，缺乏第一手资料，以医生的主观印象推断解决健康问题的方案。

2 级：对所在社区的健康问题有一定了解，有间接的二手资料，有计划和评价的能力。

3 级：通过社区调查或社区健康档案资料掌握 90% 以上居民的健康状况，针对健康问题采取解决方案，但缺乏有效的预防措施。

4 级：建立了社区居民的健康档案，掌握所有健康问题，具有有效预防和治疗的措施，建立了社区健康问题资料收集和评价系统，具有解决问题和管理社区资源的能力。

第二节 | 影响社区人群健康的因素

谈到健康问题，人们不仅考虑到疾病和伤害，而且关心所在社区可能威胁到自身健康的各种因素。一切生物总是通过调节自身，以适应不断变化的环境，同时也在不断改变着环境的状态，这种动态平衡称为生态平衡。人类不同于其他生物，能够不断地认识自然，并能动地改造自然，因而使社区的环境改变。20 世纪中期之前，影响人类健康的突出问题是传染病。生物医学模式使传染病得到基本控制，今天，科技发展使人们生活水平提高的同时，疾病谱也发生了转变。慢性病往往在人们还未觉察时就已对人体健康造成侵犯。因此，重新认识健康，认识社区生态环境的隐患及影响健康的因素，有利于对慢性病的预防。

一、影响人体健康的因素

20 世纪 70 年代末，拉隆达和德威尔提出综合健康医学模式，认为影响人类健康的因素主要有四大类：生物遗传因素、环境因素、行为生活方式因素、医疗卫生服务因素。1992 年，世界卫生组织报告指出，在人类死亡因素中，有 60% 与生活方式有关。不良生活方式和行为致死的在美国占 48.9%，我国的调查是 37.3%（表 8-1）。根据 2022 年中国卫生统计年鉴，城市居民主要疾病死因构成排前四位的有心脏病、恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病；农村居民主要疾病死因构成排前四位的有心脏病、脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病。由此可以看出影响居民死亡的疾病，已经由单纯生物因素导致的传染性疾病，转变为由生物、心理、社会等综合作用所导致的慢性非传染性疾病。

表 8-1　中美两国影响健康的 4 个主要因素占比　　单位：%

因素	生活方式和行为	人类生物学因素	环境因素	保健服务
中国（1981—1982 年）	37.3	32.1	19.7	10.9
美国（1977 年）	48.9	23.2	17.6	10.3

注：中国为 19 个城乡点，美国为全国资料。

二、环境因素对健康的影响

社会的发展越来越彰显出环境因素与社区人群健康息息相关，包含自然环境和社会环境因素两个层面。

（一）自然环境因素对健康的影响

自然环境因素主要指地理和气候因素。某些传染及自然疫源性疾病，都有较严格的地域性和季节性，形成了疾病的流行。如血吸虫病、钩端螺旋体病、出血热的流行等，皆因其自然环境适合于病原体的繁殖或传播媒介的生存。又如布鲁菌病、棘球蚴病流行于畜牧社区，是因为中间宿主牛羊的存在。蛔虫病、蛲虫病流行于卫生环境差的农村社区。地方病是在特定的社区流行。近些年气候变化对中国乃至全球影响突出，据 WHO 保守估计，由于气候变化导致的营养不良、疟疾、腹泻和热应力等影响，预计每年超额死亡人数将高达约 25 万人。据估计，到 2030 年，每年气候变化对健康的影响造

成的直接损失(不包括在诸如农业及饮用水和环境卫生等健康相关领域造成的损失)为 20 亿至 40 亿美元,因此,全球气候变化给全球人类健康带来巨大的挑战。

现代的城市社区,环境污染已成为影响健康的重大问题。近几年,我国北方多地区出现重度污染的雾霾天气,给居民健康带来严重影响。另外人们在改造环境的同时,也制造出诸多危害人们健康的因素。如,在城市社区中,废气、污水、噪声、生活垃圾、食品污染、工业粉尘、复杂的化学原料,甚至杀虫剂等,已造成极大的公害,使疾病复杂化。据世界卫生组织 2016 年报道,世界上大约有 30 亿人仍然在明火和开放式炉灶中使用固体燃料在家进行烹饪和取暖,这种方式会造成高度室内空气污染,产生大量对健康有害的污染物,包括会渗透到肺部深处的微细颗粒。据统计,每年我国由于室内空气污染引起的死亡人数超过 10 万,同时,严重的室内环境污染也造成了我国每年超过 100 亿美元的经济损失。环境对健康的影响是不容忽视的,提高人们对环境的关注度以及预防与治理能力,刻不容缓。

(二) 社会环境因素对健康的影响

社会环境因素是一个博大而空间化的概念,主要涵盖社区的文化背景、教育水平、经济因素和社会心理因素。

1. 文化背景 社区的文化背景,决定着人群的健康信念、就医行为和对健康维护的态度,影响着群体的生活行为方式和自我保健的态度。社区的社会文化,包含了思想意识、风俗习惯、道德法律、宗教以及文化教育等。社区文化主要从环境文化、制度文化、行为文化、精神文化等层面对居民健康产生影响。风俗习惯是特定社会文化区域内人们历代传承、共同遵守的行为模式或规范,贯穿于人们的衣、食、住、行、娱乐、体育、卫生等各个环节,每个国家都有固定的风俗习惯,对人群健康产生不同的影响。对于不利于人们健康的风俗除了采用法律法规等强制性措施,更应该采取说服教育的方式,使人们自觉摒弃不良风俗,维护自身健康。

2. 教育水平 除医疗卫生对健康产生影响,健康还受到行为与生活方式、饮食习惯、教育环境、遗传等因素的影响,而行为与生活方式、饮食习惯等与受到的教育程度有关。一方面,教育会提高人们对健康的认识,自觉选择有利于健康的生活方式,并且会通过体育锻炼、戒烟戒酒、食用绿色健康食品等保持身体健康。在意识到自身患病时会积极寻求卫生服务。另一方面,受教育程度提高,人们获得的就业机会相对较多,劳动收入增加,从而可以投入更多的经济、精力以改善自身健康。

3. 经济因素 经济因素是重要的社会因素,经济发展对健康的影响既有有利的一面,也有不利的一面。一方面,经济发展与医疗卫生事业的发展是相互关联的,经济发展能够增加对医疗卫生事业的投入,提高居民物质生活水平,使人群健康改善、人均寿命延长;同时,居民健康水平的提高,可以增加劳动力供给,提高劳动生产率,推动经济持续发展、促使人们丰衣足食。另一方面,若人群自我保健意识滞后,经济发展也带来新的健康问题。如今经济的发展、科技的发达,极大地改变了人们的生活方式和生活习惯,心脑血管病、肥胖、糖尿病、电视综合征、交通车祸、运动缺乏症等严重地影响群体健康。相反,经济欠发达社区,营养不良、贫血、佝偻病、维生素缺乏等疾病,也严重威胁着人群健康,因病致贫、贫病交加,又制约了社区劳动力及经济的发展。

4. 社会心理因素 根据世界卫生组织的定义,心理健康不仅是没有心理方面的疾病,而且是指一种良好的自我状态,即个体能够认识自身潜能、应对生活压力、富有成效地进行工作,并对社会有所贡献。社会心理因素对人群健康至关重要,是招致心理和躯体疾病的重要原因。心理因素常与社会环境联系在一起,环境的不良刺激影响人的情绪,生活节奏快、人际关系复杂、工作竞争给人们带来紧张和压力,产生心理失衡、焦虑、抑郁等,甚或精神疾病、自杀。长期的不良刺激招致心因性疾病,如溃疡病、高血压、心脑血管病等。心理因素也是癌症的致病原因,研究表明癌症发生前患者多有焦虑、失望、抑郁或压抑愤怒等情绪。

我国政府高度重视社会环境因素对居民健康的影响,并将文化、教育、经济、社会心理上升为国家健康战略,如“健康中国 2030”明确指出:在文化方面,要加强居民的精神文明建设,大力发展健康文化,使居民自觉地移风易俗,形成良好的生活习惯。在教育方面,把健康教育纳入国民教育体系,让健

NOTES

康教育贯穿所有教育阶段，使其成为素质教育的重要内容。在经济方面，推动健康领域基本公共服务均等化，维护基本医疗卫生服务的公益性，促进社会公平公正，减少因经济的不平等造成的健康不平等。在社会心理方面，加强对抑郁症、焦虑症等精神障碍性疾病的干预，加大对重点人群心理问题的健康管理，做到及早发现，及时提供帮助。

三、生物因素对健康的影响

（一）传染性疾病对健康的影响

随着医疗技术的发展，传染病的防治取得突破，烈性传染病得到控制，但有些地区仍时有发生，如肝炎，导致慢性肝炎—肝硬化—肝癌，严重危害居民的健康。近年结核病也呈上升趋势，多发于青少年及老人，农村地区最为严重。细菌性痢疾、流行性感冒、血吸虫病、疟疾、狂犬病、出血热、感染性腹泻等时有发生；风疹、水痘、流行性腮腺炎、炭疽、布鲁菌病亦有发病；烈性传染病霍乱、鼠疫也有报道；新生的严重急性呼吸综合征（SARS）、新型冠状病毒感染、H5N1 禽流感及疯牛病等，依然威胁着世界不同地区人们的健康。1996 年乙类传染病增加新生儿破伤风和肺结核；2002 年增加 HIV 感染；2003 年增加 SARS；2005 年增加血吸虫病和人禽流感；2009 年增加甲型 H1N1 流感；2013 年增加人感染 H7N9 禽流感；2020 年新型冠状病毒感染纳入乙类传染病管理。现今传染病至少有 30 余种，威胁着世界 1/2 的人口。传染病的预防和管理，是社区医生不可忽视的责任。

（二）慢性疾病对健康的影响

慢性非传染性疾病和退行性疾病，成为当代人群的主要疾病谱。目前，慢性病是造成世界范围内死亡和伤残的最主要原因，据世界卫生组织估算，每年约 3 800 万人死于慢性病。在我国，80% 的死亡和 70% 的伤残调整生命年损失是由慢性病造成的。慢性病具有病程长、病因复杂、很难治愈、发病率高、死亡率高、致残率高等特点。慢性病是由不良的生活方式和行为引起的疾病，慢性病的发病与吸烟、酗酒、膳食不合理、体力活动不足、心理因素等密切相关。高血压、心脑血管病、肿瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、风湿病、红斑狼疮等慢性疾病，使人们长期遭受疾病折磨，严重地影响生活质量，降低人们的幸福感。但是此类疾病缺乏有效的治疗方法，更有利的途径是及早预防。因此，如何提高人们对疾病预防的认识，做到早发现、早诊断、早治疗，成为预防慢性疾病的关键。

（三）年龄、性别、遗传性疾病对健康的影响

年龄、性别和遗传因素对个体健康状况产生重要影响。随着年龄的增长，对于一些疾病的患病风险会增加，并且不同年龄组易患疾病的种类不同。由于男女生理结构上的差异，对一些疾病的患病情况也不同。2010 年《柳叶刀》刊登一篇关于性别对健康的影响的文章，指出心脏病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等疾病的发生与预后均存在男女性别差异。随着医学技术的发展，对遗传因素的认识越来越多，其中遗传性疾病给健康带来严重危害，据估计人群中约有 25%~30% 受遗传病的危害，单基因遗传病占 10%，多基因遗传病占 14%~20%，染色体有关的疾病约占 1%，造成了严重的疾病或畸形。V.A.Mckusick 编著的《人类孟德尔遗传》一书指出，1966 年认识的单基因病有 1 487 种，至今已达 4 023 种。遗传疾病造成智力障碍儿童，给家庭和社会带来了沉重负担。许多常见病如精神病、糖尿病、动脉粥样硬化、恶性肿瘤都与遗传相关。近亲繁衍导致遗传病，在偏远地区并未完全消失。社区卫生服务中心应宣传婚前检查、生育指导、围产期保健、宫内诊断等知识，预防遗传病的发生。

四、生活方式及行为对健康的影响

生活方式是在维持生存、延续种族和适应环境的变化过程中形成的行为模式，因此，传统的生活习惯是较难改变的，但不是不能改变。社会进步使人们逐渐认识到，不良的生活方式是影响健康的重要因素。世界卫生组织曾列举了 18 种最不健康的生活方式，包括吸烟、高脂高热量饮食、过量饮酒、缺乏运动、长期过劳、情绪不佳、酒驾、不洁饮食、药物依赖或药物成瘾、对有毒废物不处理、失眠、有病不就医、不遵医嘱服药、高糖高盐饮食、家庭或婚姻生活不和谐、纵欲、社会行业适应不良和迷信及赌

博行为。“生活方式疾病”被世界卫生组织列为21世纪威胁人类健康的“头号杀手”。大量研究表明，许多慢性疾病发病率增高，与不良的生活方式及不健康行为密切关联。因此，应采取全人群策略和高危人群策略促进健康。慢性病重在一级预防，这是赋予社区医疗的艰巨任务。据统计，改变人们的生活方式可起到70%的作用，而医疗技术只起到30%的作用。全科医生应重视矫正群体的偏离行为，目前我国社区居民主要存在以下的不良行为。

（一）吸烟

吸烟是当今世界人类健康的最大威胁。世界卫生组织指出，全球每年因吸烟导致的死亡人数高达600万，超过因疟疾、艾滋病、结核导致的死亡人数之和。到2030年，预计每年死亡人数将上升到800多万。我国是世界上最大的烟草生产和消费国，目前我国每年死于与吸烟有关疾病的人数达100万，如对吸烟流行状况不加以控制，预计到2050年死亡人数将突破300万。烟草成分对肺、血管、脑组织有严重危害，一些成分是致癌物质。吸烟者患癌症的相对危险度是不吸烟者的10~15倍，约80%以上的肺癌与吸烟（包括被动吸烟）有关。通过控烟，可以预防肺癌、食管癌、口腔癌及喉癌、膀胱癌、胰腺癌，以及支气管炎、肺气肿、冠心病等。吸烟已成为我国的公共卫生问题，然而戒烟是一项漫长而艰巨的工作，应综合运用价格、税收、法律等手段提高控烟成效。可通过进行各种戒烟相关的卫生宣教，创造不利于吸烟的环境，禁止青少年及孕妇吸烟，禁止公共场所吸烟，张贴吸烟有害的警告，提供戒烟帮助，禁止烟草广告、促销和赞助，增加烟税和提高烟价等措施。尤其应对中小学生加强教育，通过他们制约家庭吸烟，阻断下一代吸烟行为。对于二手烟，通过控烟知识宣传和控烟政策实施，提高人们对二手烟暴露危害的认识，通过全社会的力量，减少二手烟危害的发生。

（二）酗酒

2022年世界卫生组织报告指出，全球每年共有300万人因有害使用酒精而丧生，占所有死亡人数的5.3%。大量饮酒对身心危害极大，可诱发急性重症肝炎、胃肠出血、脑出血、冠心病等疾病，从而危及生命；酒精可通过胎盘影响胎儿发育。酒后引发车祸、打架斗殴、犯罪、破坏家庭等一系列社会问题。长期大量饮酒是脂肪肝、酒精性肝硬化的重要原因。因此，应通过社区健康教育，使人们认识酒精的危害，避免酗酒带来的健康隐患和不良后果。

（三）膳食不合理

因一些社区人群缺乏合理饮食的认识，造成营养不良与营养过剩，已成为全球营养失衡的双重负担。一方面一味追求营养，使肥胖儿童明显增多，他们将成为未来心血管病、高血压、糖尿病的后备军。另一方面，一些人群饮食以咸菜、腌菜、辛辣食物及粮食为主，是贫血、维生素缺乏、佝偻病、高血压等和体质虚弱的原因。江南地区，居民喜食熏烤、油炸食品，使得胃癌、肝癌等消化系统恶性肿瘤成为当地居民健康的威胁。膳食不均衡及不良饮食习惯是慢性病高发的诱因，社区卫生服务中心应根据当地社区的饮食弊端进行针对性的宣教，帮助人们建立健康的饮食习惯。提倡饮食合理，不暴饮暴食、偏食和忌食，以合理膳食去除隐患、确保健康。

（四）体力活动不足

运动能调节神经系统、促进血液循环、维持肌肉骨骼功能；能促进胃肠功能、增加食欲和帮助消化；消耗多余热量、防止肥胖。研究证明，肥胖、冠心病、高血压都与缺乏运动有关。同时静坐或体力活动不足是引起残疾和死亡的重要原因之一。2020年世界卫生组织《关于身体活动和久坐行为指南》指出：身体活动对成年人健康的好处包括：降低全因死亡率、心血管疾病死亡率，减少高血压、2型糖尿病、癌症、精神异常（减轻焦虑和抑郁症状），提高认知能力、改善睡眠以及预防肥胖。

（五）药物滥用

医疗需求增高及缺乏秩序化，使药物滥用较为普遍。在双向转诊尚未完善之际，人们求治于各种渠道，得到品种繁多的药品。滥用药品，造成了药物的依赖以及副作用的影响增多，甚至导致疾病。

其中吸毒则是更严峻的问题，鸦片、海洛因、可卡因、摇头丸等易成瘾的麻醉剂，不仅使人丧志、丧德、丧失生命，而且容易传播梅毒、乙型肝炎等传染性疾病，给个人、社会造成严重的消极影响。

（六）不端性行为

不端性行为可引起艾滋病、梅毒、淋病、性病性淋巴肉芽肿等疾病，严重损毁人的健康。根据疾控部门权威数据统计，目前性传播已成为中国艾滋病传播的主要途径。艾滋病不仅对个体的身心健康造成威胁，影响感染者的工作生活，而且会引起社会恐慌，使感染者受社会歧视。

（七）网络成瘾及过度使用手机

随着科学技术的发展，互联网已成为人们了解信息、沟通、学习、娱乐的重要平台，通过网络实现多种功能的智能手机，更是成为人们生活中不可缺少的一部分。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 51 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2022 年 12 月，我国网民规模达 10.67 亿，互联网普及率达到 75.6%。其中，手机网民规模达 10.65 亿，手机网民占整体网民的 99.8%。越来越多的人过度使用手机，甚至有手机成瘾的倾向。研究表明，手机成瘾不仅对个人学习和人际关系造成负面影响，还会降低个体对生活的满意度，产生抑郁、焦虑甚至自杀的倾向。因此，在日常生活中，我们在享受网络提供便捷服务的同时，要正确地对待网络，充分发挥网络的积极作用，避免网络成瘾。

不良的生活方式严重影响居民的健康，已引起政府的高度关注，将控制吸烟、酗酒，加强体育锻炼等措施上升为国家战略，“健康中国 2030”规划纲要提出明确要求：①吸烟：到 2030 年 15 岁以上人群吸烟率降低到 20%；②饮酒：加强对居民限酒的健康教育，减少酗酒；③体育锻炼：加强居民健身公共设施建设，大力发展居民喜闻乐见的运动项目，鼓励开发民间传统运动项目，以此提高全民身体素质。

五、健康照顾系统对健康的影响

人群的健康状况与社区的健康照顾系统密切相关，社区的健康照顾系统是指社区的卫生、医疗和卫生人力的统筹安排。人群能否得到有效的健康照顾，与社区有无高水平的全科医生及医疗的可及性大小极为相关，是常见病多发病能否在社区得到合理防治的关键。

社区健康照顾机构对人群健康影响主要体现在人们在那里是否能够得到及时有效的治疗或及时转诊，且治疗措施的花费是否与患者的经济承受能力相适应。当前我国社区健康照顾的瓶颈，是缺乏高品质的家庭/全科医生和有效的廉价药物。对此“健康中国 2030”规划纲要提出：到 2030 年 15 分钟基本医疗卫生服务圈基本形成，每千常住人口注册护士数达到 4.7 人，使社区照顾更便捷。

第三节 | 社区诊断

自从有了以社区为范围服务的理念后，社区诊断显得十分必要。要不断消除社区内疾病的共同危险因素、维护社区群体的健康，只有进行社区诊断才能实现。因此，社区诊断是为减少疾病、为临床服务，并不等同于纯粹的流行病学调查，两者目的虽同，但侧重不同。

一、社区诊断概述

（一）社区诊断的概念

社区诊断（community diagnosis）最早出现于 1950 年，由于其将疾病的诊断从个体扩展到群体（表 8-2），因此具有革命性的意义。社区诊断以流行病学为基础，关注与社区人群相关的发病因素和环境因素对健康的影响，目的是探明群体的发病机制。其基本的目标与传统的公共卫生相似，即预防、控制和消除疾病。

表 8-2 社区诊断与临床诊断比较

项目	社区诊断	临床诊断
对象	群体	个体
症状	患病率、死亡率、十大死因、环境污染	头痛、发热、腹泻、出疹
检查	社区资料、社区调查	病史、体格检查、实验室检查
诊断	为健康问题制订社区卫生计划	病名 1、2、3……罗列
治疗	干预计划、评估效果	治疗计划

以社区为范围的服务，其一是社区医疗；其二是社区诊断。以社区诊断评估社区的健康问题，制订卫生计划，实施群体干预的措施，有目的、有针对性地改善社区人群的健康状况，提升整体的健康水平。实施社区诊断，应熟知整个社区的概况，掌握社区的人口结构、人口动态、居住分布、文化、职业结构等，以及社区的地理位置、气候条件、历史文化背景等环境资料，人们的健康意识、行为方式、疾病状况、危险因素及高危人群的分布，即整个社区的人文地理环境，综合分析判断社区常见突出的健康问题和所需的卫生服务，并设定解决问题的顺序。

（二）社区诊断的目的

1. 发现社区的健康问题，辨明社区的需要与需求。
2. 判断造成社区健康问题的原因，了解解决问题的程度和能力。
3. 提供符合社区需求的卫生计划资料。

（三）社区诊断所需的资料

做社区诊断之前，需要收集所需的资料及所用指标，主要包括以下方面。

1. 社区人群健康状况 主要反映在社区的人口学特征、疾病发生情况、死亡情况、居民生活习惯和行为方式等方面。

（1）人口学指标：包括人口数、人口年龄性别结构、人口增长率、平均期望寿命等。

（2）疾病指标：各种疾病的发病率、患病率，社区疾病谱的变化及影响因素等。

（3）死亡指标：包括死亡率、年龄别死亡率、疾病别死亡率、死因构成比及死因顺位等。常用的有慢性病死亡率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等。

（4）反映居民生活习惯和行为方式的指标：如吸烟率、吸烟量、饮酒率、饮酒量及食盐消耗情况等。

（5）反映居民健康意识、求医行为的指标：如体育锻炼情况、刷牙率、定期体检率等。

2. 社区环境状况

（1）自然环境：包括地理位置、气候、地貌、矿产资源、江河湖泊、耕地、病媒昆虫密度等，地理条件和安全饮用水普及率，卫生厕所使用率，空气、水、土壤污染情况，家庭及工作、学习环境的卫生状况等。

（2）社会环境：包括社区风俗习惯、文化教育、政治、宗教、公众道德修养、经济水平和产业结构，人群的消费观念，家庭结构及功能，人口流动、社会秩序、社团活动及其影响等。

（四）社区诊断的步骤

1. 收集整理资料 收集原有的相关统计资料、社区调查资料、健康筛查资料，社区访谈资料，常规上报的数据等。关键是根据社区的需求，有目的地收集有关的资料。将本社区突出的健康问题，与权威机构的信息及其他信息做比较，沉淀出真正的健康问题。

2. 确定社区主要健康问题及优先解决问题的顺序 依据以上收集、调查的结果，根据本社区当前的需求，社区资源状况的可行性，设定卫生计划及目标。以急需、可行及易行的具体情况，做出先后次序的安排，制订可实施的“社区干预计划”。

NOTES

3. 实施社区计划　一旦计划确定，应制订切实可行的实施方案，并付诸行动。在实际操作中，要准备好实施中使用的表格，并进行详细记录，以便后续统计。要有清晰的思路和明确的目标，才能有序地进行。工作进展中，需要使用调查表格、统计表格、综合及分析表格。

4. 计划效果评估　将在人群中实施的真实记录（表格），经过系统的整理及统计分析，得出本次行动的效果，并进行效果评估。其中，包括计划进行中评估及计划结束后评估。计划进行中评估，是对计划进行阶段性评估，以及了解计划与推进情况，并对计划做必要的修正。比如对难以实施的细节作调整，以便计划顺利进行。计划结束后评估，是对整个计划的效果进行评估，并提出改进意见，作为下一次社区诊断计划的参考。

根据上一次社区诊断结果，再进行下一次诊断，周而复始地解决社区群体的健康问题，从而不断提高人群的健康水平。

社区诊断关注其定向的目标——社区，其干预的是人群中的危险因素，而不是单一的病因。社区诊断的步骤见图 8-2。传统的流行病学，最早用于传染病预防，而当今社区的健康，涉及广泛的环境、社会和人的生活行为心理因素，因此，社区诊断是从生物、心理、社会环境的角度，审视并治理群体的健康问题。

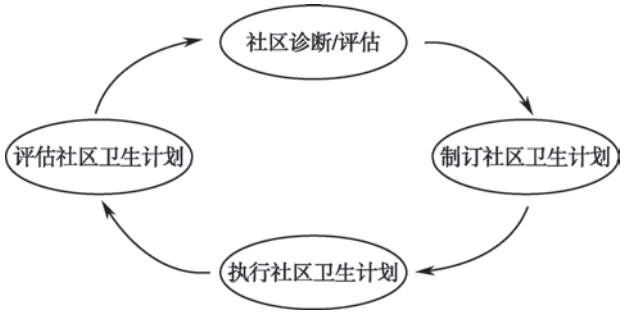


图 8-2　社区诊断步骤

二、社区调查

社区诊断是防治社区疾病的重要方法，但社区诊断的资料来源于社区调查，如何做好社区调查呢？全面的社区调查范围包括人群健康状况、社区环境状况、资源的可动员潜力，以及居民的健康意识、对卫生事业的关心程度、居民素质、政策倾向等。因此，社区调查应具有真实及实用性。

（一）社区调查的步骤

1. 设计　社区调查之前，首先进行调查设计，即制订调查计划、明确调查目的、调查对象和调查方法及如何组织开展调查和分析收集到的资料等。调查设计是调查研究过程的全面设想，保证调查研究有的放矢，以较少的人力物力取得较好的效果。

2. 实施　实施阶段包括调查员的培训、调查表的准备、资料的收集等。人员的培训包括调查的内容、人员的业务知识及沟通技巧。调查表格，应按不同需求设计调查表、统计整理表、综合分析表等，以便系统地总结和分析。

3. 分析　主要是对收集到的资料进行整理分析，并结合专业知识统计推断，揭示社区人群健康状况的规律及致病危险因素。写出调查报告，总结通过本次调查得到了哪些资料，发现了什么问题，说明了什么问题，以及调查过程中存在什么问题、应如何改进等。

（二）调查计划的制订

一个科学严谨的调查计划，包括以下内容。

1. 确定调查目的和调查指标　首先根据社区卫生工作的需要，明确调查目的。如，了解居民患某病与环境污染的关系等。明确调查目的后，根据相关知识把调查目的具体化到调查指标。

2. 确定调查对象和观察单位　根据调查目的和调查指标确定调查对象，划定调查的范围。包括空间范围、时间范围、人群范围等。

3. 选择合适的调查方法　根据不同目的选用调查方法，了解总体参数，可用普查或抽样调查；拟说明事物的典型特征，可用典型调查；研究事物的相关关系，如病因研究中了解某病的发生与个人的某些特征、习惯、既往经历、生活或生产环境有无联系，可采用病例对照研究或队列研究。在实际工作中，常须结合各种调查方法。

4. 搜集资料的方法 原始资料，常采用直接观察法和采访法进行搜集。前者是调查员到现场对观察对象直接观察、检查、测量或计数取得资料；后者是根据被调查者的回答搜集资料，往往采用访问、开会、信访等方式。

5. 确定调查项目和调查表 调查项目是根据调查指标确定的，分为分析项目和备查项目。分析项目，是直接用于计算调查指标及分析排除混杂因素所必须的内容。备查项目，是为保证分析项目填写完整正确，便于核查、补填和更正而设置的，不直接用于分析。项目的定义要明确，如疾病分型，正常和异常的界限应明确规定。项目的答案有两种设计，包括：①固定选择答案，如高血压的调查列出“是、否、可疑”可选答案；②自由选择答案，即不限制答案范围，让调查对象谈自己的意见。

把调查项目按提问的逻辑顺序列成调查表格，调查表的格式可分为一览表和卡片。一览表填写方便，每张表可填写多个观察单位，适用于项目较少的调查。卡片每张只填写一个观察单位，适用于观察单位和项目较多时。

6. 制订调查的实施计划 包括调查的组织领导、宣传动员、时间进度、调查员培训、任务分工与联系、经费预算、调查表、宣传资料准备、调查资料的检查制度（完整性、正确性检查）等内容。调查方案一经确定不得擅自改动，需要修改时应统一进行。应编制详细的填表说明，以保证统一的理解与执行。

7. 调查资料的整理 调查搜集到的资料必须经过整理、分析，去粗取精、去伪存真，才能提示事物的本质和规律。整理计划包括以下几方面。

（1）设计分组：即将性质相同的观察单位集中到一起，使组内的共性、组间的差异性显示出来。分组方法有两种：①质量分组，按观察单位的某种属性或特征分组，如按性别、职业、病种等分组；②数量分组，按观察单位被研究特征的数量大小分组，如按年龄大小、血压高低等分组。

（2）归组方法：将原始资料归入各组的方法有：①划计法，归组采用划“正”字或“+++”来计数；②分卡法，将原始资料直接归入各组，清点卡数，计算出各组的观察单位数。

（3）设计整理表：整理表是用于原始资料整理归组的表格，是提供分析用资料的过渡性表格。常用频数分布表等。

8. 调查资料的分析 主要说明指标内涵和计算方法，消除混杂因素的方法及预期要做哪些统计描述和推断等。

三、社区诊断案例

（一）案例

（1）社区的基本情况

某地域社区常住居民52 260人，其中户籍人口33 269人（63.66%），非户籍人口18 991人（36.34%）；男性27 160人（51.97%），女性25 100人（48.03%），男女比为1.082∶1；18岁以下9 557人（18.29%），18岁及以上42 703人（81.71%），其中18岁以上人口中60~69岁2 737人（5.23%），70~79岁2 762人（5.29%），80岁及以上1 139人（2.18%）。该区的年死亡率为2.60%，疾病死因顺位为：脑血管疾病、心血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、内分泌疾病、泌尿系统疾病、意外身亡。社区卫生服务中心2022年1—8月开展了辖区居民健康抽样调查，调查方法为问卷调查结合一般体格检查，问卷内容包括居民个人基本情况，健康状况，家庭一般情况，体育锻炼、吸烟、饮酒等生活方式与行为习惯等情况。本次共调查了13 590位居民，健康问题主要是高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢性阻塞性肺疾病等慢性病，共计6 383人（46.97%），同时合并两种或以上慢性病人数1 268人（9.33%），主要分布在60岁以上老年人群中。调查显示4 436人（32.64%）缺乏体育运动，27 86人（20.50%）超重，636人（4.68%）饮酒，511人（3.76%）吸烟。

综合分析后得出以下结论：慢性病防控是本社区需要优先解决的卫生问题，主要行为危险因素依次为体力活动不足、超重、吸烟、饮酒。根据以上情况，着手逐步改善社区的健康状况。

（2）解决卫生问题的次序

1）体力活动不足。

2）不良的生活习惯问题。

3）慢性病预防管理问题。

4）合并多种慢性病的问题。

（3）卫生行动计划（立即付诸行动）：把慢性病干预、综合防治体系纳入社区整体规划中，在这个基础上，积极进行社区干预。

1）依据患者的具体情况，完善健康体检以及健康档案。

2）开展责任医师制度，通过日常门诊和随访，从行为改变到服药规范、自我管理倡导，加强社区慢性病的三级预防。

3）开展健康教育，提高慢性病患者对慢性疾病的知晓率、服药率及控制率。开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、戒烟、限酒、科学就医、合理用药等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育。

（4）执行和评估卫生计划：包括卫生计划落实如何，执行的效果如何，下一步计划的修改。

1）卫生宣教力度如何？知识讲解水平怎样？群众是否听懂或乐于接受？

2）是否充分挖掘了社区资源，其他医疗机构包括儿童保健、妇女保健、防疫配合情况，镇、村委会的支持情况。

3）慢性病诊断水平及治疗效果，群众的经济承受能力。

4）各类慢性病患病率是否降低，卫生常识水平是否提高。

（5）下一步社区诊断：通过以上实施后的效果评估，结合当前社区的突出健康问题，制订下一轮社区卫生计划。

以上是一个社区诊断过程的案例，从中可以发现，调查的疾病与实施的卫生计划是完全不同的内容。疾病是指社区主要面临的疾病或死因；卫生计划，是将要付诸的实际行动，目的是从社区的主要疾病中寻找出其发病的危险因素及预防途径和措施。

社区诊断是通过一定的方法和手段收集社区相关资料，用科学、客观的方法对社区主要的公共卫生问题及其影响因素进行分析，以了解所辖社区居民健康状况，制订和实施社区综合防治计划，提升社区健康水平，且上一次的社区诊断将作为下一步社区诊断的依据和基础，形成周而复始的运作过程。

（二）社区诊断的实际意义

1. 适合社区　居民如有不良生活方式和生活习惯，社区医生能够及时纠正、随时处理。

2. 便捷经济　社区诊断操作不需要先进设备及高级技术，适合基层卫生服务。

3. 公共卫生管理　社区中与疾病和健康相关的公共卫生问题是经常发生的，产生于人群与生活之中，走进人群、辨明群体的发病机制，是社区医学的创意和有效的公共卫生管理。

4. 适合慢性病　当今人类已进入慢性病时代，疾病的发生源自日常的生活行为与危险因素。因此，常抓不懈的社区诊断将是今后早期预防、减少患病的途径。

5. 辨明社区表证　在社区诊断的实施过程中，逐渐查出社区的主要疾病及死因，即社区的“表证”；而以其表证寻求本社区的预防目标，制订行动计划和防治重心，成为科学有序的社区卫生管理机制。

6. 提升健康水平　不断地发现隐患，持续的健康管理，周而复始的社区诊断，最终必然促进整体人群健康水平的提升——社区康复。

社区诊断是围绕社区医疗的工作，有明确的目的性。比如一个社区高血压患病率比其他社区高，经社区诊断调查后，发现这一社区人们习惯腌咸菜，得出群体的发病机制“摄盐过多”，通过健康教育、改善旧的生活习惯，使疾病得以控制。因此，社区诊断强调了不同的社区有不同的特征及卫生问

题，即前面谈到的“强调不同社区的不同需求及自主性”。当然，社区诊断的执行，应考虑社区医疗的范围及能力。

（李洁华）

思考题

1. 阐述社区医学的重要意义。社区医学分几个发展阶段？
2. 影响社区人群健康的主要因素有哪些？
3. 阐述社区诊断的步骤、方法及实际意义。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图